Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Espumoso

Rua Independência, 212 - Bairro: São Jorge - CEP: 99400-000 - Fone: (54) 3046-9882 - WhatsApp (54) 9712-5167 - Email: frespumosovjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001865-04.2022.8.21.0046/RS

AUTOR: MARIA LAUDELINA SOARES DE CAMARGO
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RÉU: MUNICÍPIO DE ESPUMOSO

SENTENÇA

MARIA LAUDELINA SOARES DE CAMARGO ajuizou "*AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS*" em face de **MUNICÍPIO DE ESPUMOSO** e **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** (evento 1, INIC1), requerendo, com pedido de tutela antecipada, que fosse determinado aos demandados o fornecimento de tratamento de saúde por meio dos medicamentos receitados. Informou ter sido diagnosticada com carcinoma de mama metastático tipo luminal, um tipo de câncer. Disse que seu tratamento envolve os medicamentos Faslodex (Fulvestranto), Ibrance (Palbociclibe), e Prolia (Denosumabe), que têm contribuído para sua recuperação. Declarou que vendeu suas terras e demais patrimônios para custear parte do tratamento e afirmou ter uma dívida de R$ 27.447,12 com o plano de saúde. Relatou que, após esgotar seus recursos financeiros, solicitou os medicamentos junto à secretaria municipal de Espumoso, mas o fornecimento foi negado. Pleitou AJG. Juntou documentos.

Foi concedida a tutela de urgência e deferida a gratuidade de justiça (evento 3, DESPADEC1, evento 8, DESPADEC1).

Citado, o Município de Espumoso apresentou contestação (evento 18, CONT1). Preliminarmente, suscitou que é caso de litisconsórcio passivo necessário, alegando que a União deve compor necessariamente o polo passivo. Mencionou que os medicamentos solicitados pela autora têm um custo elevado, totalizando R$ 28.532,96 mensais, conforme os orçamentos apresentados. Disse que esse valor compromete significativamente o orçamento mensal de um município do porte de Espumoso, devendo ser observado o princípio da reserva do possível. Requereu o acolhimento da preliminar e/ou a improcedência dos pedidos efetuados pela parte autora.

Citado, o Estado apresentou contestação (evento 35, CONT1). Suscitou, preliminarmente, ilegitimidade passiva, pois (i) o tratamento deve ser custeado pelo plano de saúde particular mantido pela parte autora com a Unimed (UNIMED PLANALTO MÉDIO) e (ii) é da União a responsabilidade do tratamento em tela, pois de alta complexidade. No mérito, fez considerações sobre a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer e ratificou as teses apresentadas em sede de preliminar. Requereu, assim, o acolhimento das preliminares e, ao final, a improcedência dos pedidos.

Houve réplica (evento 63, RÉPLICA1).

As partes foram intimadas acerca do interesse na produção de outras provas, tendo a parte autora e o Município pleiteado o julgamento do feito, enquanto o Estado requereu a intimação da parte autora para juntar aos autos o contrato do plano de saúde que possui com a UNIMED PLANALTO MÉDICO, bem como informação sobre a negativa do fornecimento do tratamento (evento 76, PET1, evento 78, PET1, evento 87, PET1).

Foi deferido o pedido de prova formulado pelo Estado (evento 89, DESPADEC1).

No evento 95, PET1, a parte autora juntou os documentos solicitados.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relato.

Decido.

De início, enfrento as preliminares arguidas pelos réus, em sede de contestação.

Afasto a preliminar do Estado de que não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação porque a parte autora possui plano de saúde particular.

O fato de o cidadão ser conveniado a plano de saúde particular não afasta, por si só, o direito à saúde a ser suprido pelos entes estatais como garantia constitucional.

Neste sentido, a jurisprudência do TJRS

> *EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EFEITO INFRINGENTE. OMISSÃO SUPRIDA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE (ECA E IDOSO). ESTADO E MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. FORNECIMENTO DE FITOTERÁPICO DERIVADO DO CANABIDIOL. AUTOR DIAGNOSTICADO COM EPILEPSIA E PARALISIA CEREBRAL, CUJO TRATAMENTO REQUER O USO DE PROMEDIOL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS. REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES ESTRUTURADA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PROCESSO SENTENCIADO ANTERIORMENTE À DATA DE 17-04-2023. PROSSEGUIMENTO DA TRAMITAÇÃO NO JUÍZO ESCOLHIDO PELA PARTE LITIGANTE. SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, AO MENOS POR ORA, VEDADA A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. SOLUÇÃO AJUSTADA AO QUE DECIDIU O EG. STF EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA*

INCIDENTAL NO RE Nº 1.366.243/SC (TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL), APÓS O JULGAMENTO DO IAC Nº 14 PELO STJ. Por ocasião da análise de tutela provisória incidental postulada no bojo do RE nº 1.366.243/SC (Tema 1.234 da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, "diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, (...) os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução".Situação concreta em que o processo foi sentenciado antes da data de 17-04-2023, impondo-se, ao menos enquanto não julgado em definitivo o Tema 1.234/STF, o prosseguimento do feito na Justiça Estadual, independentemente da discussão envolvendo a repartição de responsabilidades dos entes federativos no âmbito do SUS. AUTOR FILIADO A PLANO DE SAÚDE PRIVADO. VIABILIDADE DE PLEITEAR O TRATAMENTO PELA REDE PÚBLICA. Embora a parte autora seja segurada de plano de saúde particular, tal não arreda a legitimidade passiva "ad causam" dos corréus, uma vez assente a responsabilidade solidária dos entes federados pela concessão do tratamento pleiteado. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. OMISSÃO SUPRIDA. APELO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE CONHECIDO E DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50953463020208210001, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 21-03-2024)

SAÚDE. TRATAMENTO. PLANO DE SAÚDE PARTICULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. TRATAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. 1. Tema 793 do STF. "O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente". 2. A contratação de plano de assistência à saúde privado não exonera os entes públicos do dever de garantir ao beneficiário o direito à saúde por meio do SUS, ainda que prevista cobertura para a enfermidade que o acomete, ressalvado o direito de ressarcimento relativamente ao Plano de Saúde. Tema 345 do STF. 3. Nas ações relativas à dispensação de tratamentos, procedimentos, materiais, insumos ou medicamentos não incorporados ao SUS, por ora, está vedada a determinação de inclusão da União. Aplicação da tutela provisória incidental concedida no RE 1.366.243 (Tema 1.234 do STF). 4. Tema 1.161 do STF. "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS". Hipótese em que estão presentes os requisitos para a concessão do fármaco à base da substância canabidiol ante o laudo médico atestando a ineficácia dos tratamentos disponibilizado pelo SUS e a hipossuficiência econômica da autora. 5. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública relativamente ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz. Tema 1.076 do STJ. Hipótese em que é de ser mantida a verba honorária fixada em primeiro grau. Recursos desprovidos. Voto vencido.(Apelação Cível, Nº 50021724520198210051, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Redator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 20-07-2023)

Não há falar, portanto, em ilegitimidade passiva do ente estadual.

Com relação à necessidade de inclusão da União no polo passivo do feito, levantada pelos requeridos, sob o enfoque do Tema nº 793 do STF, ainda que se tenha a sua aplicação como independente de trânsito em julgado, entende-se não ter ele, o TEMA 793, implicado no afastamento da solidariedade dos entes públicos nas demandas prestacionais de saúde.

O direito à saúde vem consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo um direito de todos e de responsabilidade solidária dos entes públicos, União, Estados e Municípios.

Veja-se que há decisões do mesmo STF, posteriores, a evidenciar interpretação no sentido de o TEMA 793 ter reafirmado a responsabilidade solidária.

Cita-se como exemplo a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, por ocasião do julgamento da Reclamação nº 41677/GO, em 30/06/2020, acerca da competência da União nas ações objetivando o fornecimento de medicamento:

*Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do referido Estado (TJGO), nos autos do Mandado de Segurança 5413026.25.2019.8.09.0000, **por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).** O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado não aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral, ao deixar de observar a integralidade da tese fixada no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral). É o relatório necessário. Decido. Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. Transcrevo trecho do aresto proferido pelo TJGO, ao julgar o mandado de segurança: "O Tema 500/STF, em repercussão geral, no RE 657718/MG, definiu ser de (i) competência da União a análise de causas que envolva fornecimento de fármaco não registrado na ANVISA. Devo frisar não ser o caso destes autos, pois o medicamento NIVOLUMABE é o princípio ativo do fármaco OPDIVO, registrado na ANVISA sob o nº 101800408, devendo, por esta razão, o Estado de Goiás figurar no polo passivo deste mandamus, pois, nesta hipótese, a responsabilidade pelo fornecimento da drogadição não é exclusiva da União. […] Outrossim, a legitimidade passiva do ente estatal é notória, pois "É dever da União, do Estado e dos Municípios, solidariamente, o fornecimento ao cidadão, sem ônus para este, de medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial do SUS" (destaquei), consoante dispõe a súmula 35 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. **Sobre a responsabilidade solidária existente entre os entes públicos, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral, no RE 855178-SE, Tema 793/STF, em 23.05.2019:** Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. **Assim, qualquer um dos entes poderá ser demandado, devendo eventuais ressarcimentos serem solucionados fora do âmbito da presente lide, nos termos da própria tese fixada."** (págs. 164–166 do documento eletrônico 2) Entendo que o Tribunal de origem aplicou de forma expressa o Tema 793 da Repercussão Geral, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case por ausência de observância da solidariedade na dispensação de medicamentos. Vê-se que, ao contrário do que afirma o reclamante, o acórdão combatido deixa claro que "o medicamento NIVOLUMABE é o princípio ativo do fármaco OPDIVO, registrado na ANVISA sob o nº 101800408, devendo, por esta razão, o Estado de Goiás figurar no polo passivo deste mandamus, pois, nesta hipótese, a responsabilidade pelo fornecimento da drogadição não é exclusiva da União". Ainda, **que "qualquer um dos entes poderá ser demandado, devendo eventuais ressarcimentos serem solucionados fora do âmbito da presente lide, nos termos da própria tese fixada".** Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito recente acórdão proferido pela Primeira Turma do STF, assim ementado: "CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia*

no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento." (Rcl 33.582-AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma) Cito, ainda, a decisão monocrática proferida no julgamento de reclamação semelhante ao caso dos autos, também ajuizada pelo Estado de Goiás: Rcl 41.064/GO, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Ministro Ricardo Lewandowski Relator.

No mesmo sentido, precedentes do STF, reafirmando, após o julgamento dos embargos de declaração no RE 855178 (este com decisão de julgamento datada de 23/05/2019, e acórdão, de 16/04/2020), a responsabilidade solidária dos Entes Federados no dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente:

*DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. **Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos Entes Federados no dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.** 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 963232 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020)*

*SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (**TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL).** COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CUSTO DO MEDICAMENTO. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 566.471-RG/RN). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – **O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados**. II – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. III – Inaplicabilidade do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471-RG/RN), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, à hipótese em que não há discussão sobre o custo do medicamento requerido. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1221111 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 06-12-2019 PUBLIC 09-12-2019)*

Nesse diapasão, foi a decisão monocrática no Conflito negativo de competência de nº 177579 - RS (2021/0036469-9) pelo STJ, de 26 de fevereiro de 2021, da qual se extrai o trecho a seguir transcrito:

[...]

Ademais, é sabido que compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, assumindo inclusive os riscos inerentes a essa opção.

*A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que as ações relativas à assistência à saúde pelo SUS – fornecimento de medicamentos ou de tratamento médico – podem ser propostas em desfavor de qualquer dos entes da Federação Brasileira (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), individualmente ou em conjunto, visto que a solidariedade obrigacional entre os entes federados **não enseja a formação litisconsorcial passiva necessária**.*

A parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul. Contudo, o Juízo estadual determinou a emenda da petição inicial para incluir a União no polo passivo da demanda, sem que haja qualquer situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário.

Nesse contexto, não se vislumbra nenhuma das hipóteses do art. 109, I, da CF/1988 e, considerando que compete à Justiça Federal decidir sobre a inclusão do ente federal na relação processual, a ação em comento deve ser processada e julgada no Juízo estadual.

[...]

Ainda, de se registrar que a determinação, de ofício pelo juízo de origem, de inclusão da União no polo passivo, nas demandas que envolvem a pretensão de fornecimento de medicamentos, além de ferir o princípio da demanda e da adstrição do juiz ao pedido, vai de encontro à tese firmada no Tema 686 do STJ, que assim dispõe:

"O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde".

Por fim, o STJ, em decisão no IAC 14 determinou a abstenção de prática de ato judicial de declinação de competência pelo juízo estadual nas ações prestacionais de saúde até decisão definitiva em tal incidente:

Tema/IAC 14 Situação Admitido Órgão julgador PRIMEIRA SEÇÃO Ramo do direito DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Questão submetida a julgamento

Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de

ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.

Anotações NUGEPNAC

Admitido na sessão eletrônica iniciada em 25/5/2022 e finalizada em 31/5/2022 (Primeira Seção).

Em sessão realizada em 8/6/2022, A Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator.

Informações Complementares

Não há determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. (acórdão publicado no DJe de 13/6/2022)

Repercussão Geral

Tema 793/STF - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

Superadas as questões preliminares, passo agora a analise do mérito.

Com relação ao fornecimento dos medicamentos em si, não constantes dos atos normativos do SUS, de se registrar que foi matéria apreciada por meio do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, publicado em **04/05/2018**, referente ao Tema 106 do STJ, em que restou definida a exigência da presença cumulativa dos seguintes requisitos: **(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.**

No caso, considerando a data do ajuizamento da ação, tenho que se aplica tal tese.

Os atestados aportados aos autos demonstram a necessidade dos medicamentos: Faslodex 250 ml – com aplicação de duas ampolas/mês; Ibrance 125 mg, um comprimido via oral uma vez ao dia; Psolia 60mg, duas ampolas uma vez ao mês.

A incapacidade financeira da parte autora em arcar com o custo dos medicamentos prescritos também restou demonstrada nos autos. Por outro lado, trata-se de medicação de alto custo R$ 30.000,00 aproximadamente, por mês - o que, por si só, presume a hipossuficiência da parte autora frente ao custeio do remédio.

Por fim, os fármacos possui registros na ANVISA:

Faslodex 250 ml - registro Anvisa 116180114

Ibrance 125 mg - registro Anvisa 102160257

Prolia 60mg - registro Anvisa 1024400130011

No tocante ao alto custo do tratamento, descabe as alegações a respeito da ausência de previsão orçamentária para o custeio dos fármacos, e tampouco aquelas relativas ao alto custo dos medicamentos e aos impactos financeiros supostamente sofridos com sua aquisição.

Isso porque, é inequívoco que questões de ordem orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais que determinam a tutela do direito à saúde, à vida e, em última análise, à dignidade humana.

Da política nacional de prevenção e controle do câncer é de competência dos CACONs/UNACONs o fornecimento de tratamento de câncer, como, a exemplo do caso em análise, fornecimento de medicamento oncológico.

Entretanto, compete aos entes públicos assegurar que o medicamento postulado para o tratamento seja entregue à parte autora através dos centros/unidades especializados no tratamento do câncer mais próximo de sua residência. Em hipótese do não fornecimento imediato pelo referido Centro, caberá aos réus providenciá-lo.

Nesse sentido o seguinte precedente do eg. TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. O entendimento acerca da solidariedade dos entes da federação, nas demandas prestacionais na área da saúde, restou sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/RG com Repercussão Geral (Tema 793). Responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Cetuximabe. Reconhecida a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação de serviços de saúde, não há qualquer impedimento ao cidadão em pleitear tratamento ou medicação a qualquer ente da Federação. Compete a estes, pois, a responsabilidade ? sob pena de arcar com os custos do tratamento ?, diligenciar no encaminhamento e internação do paciente aos Centros de Alta Complexidade Oncológica (CACON ou UNACON). APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, No 70084325190, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 29-07-2020)

Ademais, descabida a justificativa de que ao Estado compete apenas a fiscalização e o repasse da verba destinada pela União aos estabelecimentos habilitados, pois ausente a responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos afetos à área de oncologia, uma vez que o respeito pelo ser humano deve se dar em todas as fases de sua vida.

Por outro lado, quanto ao fornecimento da medicação pela Denominação Comum Brasileira – DCB, basta dizer que se trata de imposição legal (art. 3º da Lei no 9.787/993). Vale lembrar, por oportuno, que a aquisição do medicamento pela sua denominação brasileira não constitui substituição do fármaco, muito menos prejuízo ao paciente.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **MARIA LAUDELINA SOARES DE CAMARGO** em desfavor do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** e do **MUNICÍPIO DE ESPUMOSO/RS** para o fim de:

a) **CONDENAR** os requeridos a fornecerem regularmente à parte autora os medicamentos Faslodex 250ml, Ibrance 125mg e Psolia 60mg, nas quantidades e especificações descritas nos receituários, de forma gratuita, enquanto perdurar a necessidade dela, sob pena de sequestro da importância necessária para aquisição, observada a DCB

b) **CONFIRMAR** a antecipação de tutela deferida no evento 8, DESPADEC1.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador da parte autora, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Os honorários serão corrigidos monetariamente pelo IPCA a contar desta data e incidentes juros de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, conforme disposição do art. 85, § 16º, do CPC.

Os entes públicos ficam isentos do pagamento da taxa única (art. 5°, inc. I da Lei 14634/2014). Condeno-os, porém, ao pagamento integral das despesas processuais (arts. 14 e 16 da Lei nº 14.634/2014), em iguais proporções, com a ressalva, ao Estado, da condução do Oficial de Justiça, se houver (Ofício Circular nº 03/2014-CGJ).

Sentença publicada eletronicamente. Intimação eletrônica.

Em havendo interposição de recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazões e remetam-se os autos à instância superior, independente de juízo de admissibilidade, conforme art. 1.010, § 3º, do CPC.

Documento assinado eletronicamente por **PRISCILLA DANIELLE VARJAO CORDEIRO, Juíza de Direito**, em 30/8/2024, às 17:5:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10066466707v24** e o código CRC **066c0887**.